

Razonamiento clínico — Cadera / ingle

bodyPart: hip · entry: hp_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 30

Entrada alternativa por test del informe

- **faber** → hp_faber
- **fadir** → hp_fadir
- **trendelenburg** → hp_lateral_trendelenburg
- **slr-lasegue** → hp_posterior_slr
- **hop-test** → hp_trauma_hop

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Cadera / ingle — árbol maestro Physioguide

id: hp_master_entry

Resumen: Flujo: red flags → trauma agudo → localización exacta → rama (groin Doha / hip-related / lateral / posterior) → historia/carga → palpación → test principal → diferencial → coexistencia.

Hipótesis:

- **Enrutar por localización del paciente** (alta) — Ingle → groin Doha; lateral → GTPS; posterior → isquio/deep gluteal; profundo → hip-related; trauma → hop/apoyo.
 - **Permitir patologías coexistentes** (media) — GTPS + adductor, hip + pubic, lumbar + posterior son combinaciones válidas.
- Continúa en: **hp_master_trauma_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Trauma agudo dominante?

id: hp_master_trauma_gate

testId: route-hip-trauma

Descripción: Caída, golpe, sprint, chute o pop reciente con hematoma o imposibilidad de apoyo → rama traumática (hop, no tests agresivos). Si es sobreuso o progresivo, continúa por localización.

Procedimiento: Enrutado clínico (no es un test físico). Elige según la historia del informe.

Evidencia: No apoyo + deformidad → urgencia. No hop si no puede apoyar.

- **Positivo / Sí:** Trauma agudo / pop / no apoyo → **hp_route_trauma**
- **Negativo / No:** Sin trauma dominante → **hp_loc_groin**

3. [CONCLUSIÓN] Rama traumatic — cadera/pelvis aguda

id: hp_route_trauma

Resumen: Hop test + apoyo + deformidad. Dolor óseo intenso → fractura/avulsión.

Hipótesis:

- **Distensión musculotendinosa aguda** (media) — Puede apoyar/saltar con dolor muscular localizado.
 - **Sospecha ósea / avulsión** (media) — Hop imposible, no apoyo o pop + adolescente.
- Continúa en: **hp_trauma_hop**

4. [TEST / GATE] ¿El dolor es inguinal / medial / púbico / profundo?

id: hp_loc_groin

testId: route-hip-groin

Descripción: Ingle, muslo interno, pubis, canal inguinal o profundo en la cadera → marco Doha + hip-related. Si no, valora lateral o posterior.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta (un dedo).

Evidencia: Ningún test resistido aislado confirma adductor ni FAI.

→ **Positivo / Sí:** Ingle / medial / pubis / canal / profundo → **hp_groin_doha**

→ **Negativo / No:** No es el dolor dominante → **hp_loc_lateral**

5. [TEST / GATE] Hop test

id: hp_trauma_hop

testId: hop-test

Descripción: Salto monopodal en la pierna afectada comparando dolor, control y distancia.

Procedimiento: Salto monopodal en la pierna afectada comparando dolor, control y distancia.

Evidencia: Post-trauma: NO si no puede apoyar. Imposible o dolor óseo intenso → fractura/avulsión ↑. También criterio RTS (no es test de labrum).

→ **Positivo / Sí:** Dolor óseo intenso / no puede saltar → **hp_trauma_bone**

→ **Negativo / No:** Puede saltar / dolor muscular → **hp_trauma_muscle**

6. [CONCLUSIÓN] Groin pain — marco Doha

id: hp_groin_doha

Resumen: Adductor: medial + aducción resistida familiar. Iliopsoas: anterior + flexión resistida. Inguinal: canal + Valsalva orientativo. Pubic: sínfisis. Ningún test aislado confirma.

Hipótesis:

- **Adductor-related groin pain** (media) — Dolor medial + aducción resistida + palpación aductor.
 - **Iliopsoas-related groin pain** (media) — Dolor anterior + flexión resistida/SLR resistido.
 - **Pubic / inguinal-related** (baja) — Palpación pubis o canal inguinal + carga abdominal.
- Continúa en: **hp_faber**

7. [TEST / GATE] ¿El dolor es lateral (trocánter) o posterior (glúteo/isquion)?

id: hp_loc_lateral

testId: route-hip-lateral

Descripción: Costado / hueso de fuera / dormir de lado → GTPS. Glúteo, isquion o al sentarse → rama posterior.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta.

→ **Positivo / Sí:** Lateral / trocánter / dormir de lado → **hp_route_lateral**

→ **Negativo / No:** Posterior / glúteo / isquion → **hp_route_posterior**

8. [CONCLUSIÓN] Sospecha ósea / avulsión / fractura

id: hp_trauma_bone

Resumen: Hop imposible o dolor óseo intenso tras trauma o carga → no tratar como tirón; imagen y/o urgencias según apoyo y deformidad.

Hipótesis:

- **Fractura de cadera o pelvis** (alta) — Trauma + no salto/no apoyo; edad avanzada aumenta riesgo.
- **Avulsión apofisaria** (media) — Joven + pop + dolor óseo local (ASIS/AIIS/isquion).
- **Fractura de estrés (si no hubo golpe único)** (baja) — Corredor + ingles progresiva + hop óseo.

→ Nodo terminal (fin de rama).

9. [CONCLUSIÓN] Compatible con distensión musculotendinosa aguda

id: hp_trauma_muscle

Resumen: Puede apoyar/saltar con dolor muscular → flexor, recto, aductor o isquio según localización; no inventar grado.

Hipótesis:

- **Distensión flexor / recto femoral** (alta) — Ingle anterior + chute/sprint.
- **Distensión aductor aguda** (media) — Ingle medial + apretar rodillas / abertura.
- **Distensión isquiotibial proximal** (media) — Isquion/posterior + sprint.
- **Labrum traumático** (baja) — Si pivote + pop inguinal + chasquido/bloqueo.

→ Nodo terminal (fin de rama).

10. [TEST / GATE] FABER / Patrick

id: hp_faber

testId: faber

Descripción: Flexión, abducción y rotación externa de cadera (figura 4). Dolor inguinal vs. lumbar.

Procedimiento: Flexión, abducción y rotación externa de cadera (figura 4). Dolor inguinal vs. lumbar.

Evidencia: Registra DÓNDE duele: ingle → cadera; posterior → SI/lumbar; lateral → GTPS. Inespecífico como diagnóstico único.

→ **Positivo / Sí:** Dolor inguinal → **hp_intraarticular**

→ **Negativo / No:** Dolor posterior, lateral u otro → **hp_faber_non_inguinal**

11. [CONCLUSIÓN] Rama lateral — GTPS / trocánter

id: hp_route_lateral

Resumen: Dolor lateral familiar + palpación trocantérica + monopodal → GTPS ↑.

Hipótesis:

- **GTPS / tendinopatía glútea** (alta) — Patrón trocantérico + carga monopodal.

→ Continúa en: **hp_lateral_branch**

12. [CONCLUSIÓN] Rama posterior — isquio / glúteo / ciática

id: hp_route_posterior

Resumen: Diferenciar isquiotibial proximal vs deep gluteal vs lumbar/radicular.

Hipótesis:

- **Isquiotibial proximal** (media) — Isquion + sentarse + estirar isquio.
- **Deep gluteal / radicular** (media) — Glúteo profundo sentado o SLR familiar.

→ Continúa en: **hp_posterior_slr**

13. [CONCLUSIÓN] Patología intraarticular de cadera

id: hp_intraarticular

Resumen: FABER con dolor inguinal sugiere cadera, no SI primaria.

Hipótesis:

- **Conflictos femoroacetabulares (FAI)** (alta) — Dolor inguinal con flexión-rotación.
- **Lesión labrum acetabular** (media) — Chasquido, bloqueo, deportes de pivotaje.

→ Continúa en: **hp_fadir**

14. [CONCLUSIÓN] Valorar origen posterior vs lateral vs SI

id: hp_faber_noninguinal

Resumen: FABER sin dolor inguinal → cribar posterior (isquio/deep gluteal/ciática) y lateral (GTPS) según localización.

Hipótesis:

- **Origen posterior / isquio / glúteo** (media) — Dolor posterior o isquial reportado.
 - **GTPS / lateral** (media) — Si dolor lateral trocantérico predominante.
 - **SI / lumbar referido** (baja) — FABER posterior sin inguinal.
- Continúa en: **hp_posterior_slr**

15. [TEST / GATE] Trendelenburg

id: hp_lateral_branch

testId: trendelenburg

Descripción: Apoyo monopodal: caída de pelvis contralateral indica debilidad glútea media.

Procedimiento: Apoyo monopodal: caída de pelvis contralateral indica debilidad glútea media.

Evidencia: Grimaldi & Fearon JOSPT 2015: cluster GTPS (palpación + carga monopodal). Caída pélvica ≠ rotura de glúteo; también L5.

- **Positivo / Sí:** Pelvis cae / dolor lateral → **hp_gtps_cluster**
→ **Negativo / No:** Trendelenburg negativo → **hp_lateral_lumbar**

16. [TEST / GATE] SLR / Lasègue

id: hp_posterior_slr

testId: slr-lasegue

Descripción: Elevación pasiva de pierna recta. Dolor ciático / radicular antes de 60°.

Procedimiento: Elevación pasiva de pierna recta. Dolor ciático / radicular antes de 60°.

Evidencia: van der Windt Cochrane: sensible, poco específico. Ciática familiar (pierna), no tirón isquiotibial. Cruzado más específico. No confirma hernia.

- **Positivo / Sí:** Reproduce dolor posterior/ciático → **hp_posterior_radicular**
→ **Negativo / No:** SLR negativo o no familiar → **hp_posterior_hamstring**

17. [TEST / GATE] FADIR

id: hp_fadir

testId: fadir

Descripción: Flexión, aducción y rotación interna de cadera.

Procedimiento: Flexión, aducción y rotación interna de cadera.

Evidencia: Warwick Agreement (Griffin BJSM 2016): FADIR familiar inguinal profundo ↑ cadera; NO confirma FAI ni labrum. Baja especificidad.

- **Positivo / Sí:** FADIR positivo → **hp_fai**
→ **Negativo / No:** FADIR negativo → **hp_trendelenburg**

18. [CONCLUSIÓN] Compatible con GTPS / tendinopatía glútea

id: hp_gtps_cluster

Resumen: Dolor lateral + carga monopodal/Trendelenburg + palpación trocantérica (si consta) sugieren GTPS; no confirman bursitis ni rotura aisladas.

Hipótesis:

- **GTPS / tendinopatía glúteo medio** (alta) — Dolor lateral trocantérico + apoyo monopodal + abducción resistida familiar.
- **Irritación peritrocantérica** (media) — Puede coexistir; no asumir bursitis aislada sin correlación.
- **Snapping externo (ITB/glúteo mayor)** (baja) — Valorar si hay chasquido lateral reproducible.

→ Continúa en: **hp_lateral_faber_screen**

19. [CONCLUSIÓN] Considerar origen lumbar / L5 referido

id: hp_lateral_lumbar

Resumen: Dolor lateral sin patrón trocantérico claro o con síntomas lumbares → cribado proximal.

Hipótesis:

- **Dolor lumbar referido (L5 / facetas)** (media) — Trendelenburg negativo + lumbar sx o SLR positivo.
 - **GTPS leve / incipiente** (baja) — Si palpación trocantérica familiar positiva, reconsiderar.
- Nodo terminal (fin de rama).

20. [CONCLUSIÓN] Compatible con irritación ciática / radicular

id: hp_posterior_radicular

Resumen: SLR positivo familiar → lumbar/radicular o deep gluteal con componente neural; exploración neurológica completa.

Hipótesis:

- **Radiculopatía lumbar / ciática** (alta) — SLR familiar + posible síntomas lumbares.
 - **Deep gluteal syndrome** (media) — Dolor glúteo profundo + sentarse; diferenciar de lumbar.
 - **Isquiotibial proximal** (baja) — Si patrón isquial claro predomina sobre neural.
- Continúa en: **hp_extraarticular**

21. [CONCLUSIÓN] Compatible con isquiotibial proximal

id: hp_posterior_hamstring

Resumen: SLR negativo + sentarse/estirar isquio/flexión resistida → tendinopatía/distensión isquiotibial proximal ↑.

Hipótesis:

- **Tendinopatía isquiotibial proximal** (alta) — Dolor isquion + sentarse + estirar isquio + carga.
 - **Distensión isquiotibial aguda** (media) — Si mecanismo sprint/chute reciente.
 - **Deep gluteal / ciático** (baja) — Si dolor glúteo profundo predomina sobre isquion.
- Continúa en: **hp_lateral_branch**

22. [CONCLUSIÓN] Conflicto femoroacetabular

id: hp_fai

Resumen: FADIR positivo refuerza sospecha de pinzamiento anterior; NO confirma FAI sin correlación clínica e imagen.

Hipótesis:

- **FAI cam/pincer** (alta) — Flexión-aducción-RI dolorosa familiar.
- Nodo terminal (fin de rama).

23. [TEST / GATE] Trendelenburg

id: hp_trendelenburg

testId: trendelenburg

Descripción: Apoyo monopodal: caída de pelvis contralateral indica debilidad glútea media.

Procedimiento: Apoyo monopodal: caída de pelvis contralateral indica debilidad glútea media.

Evidencia: Grimaldi & Fearon JOSPT 2015: cluster GTPS (palpación + carga monopodal). Caída pélvica ≠ rotura de glúteo; también L5.

- **Positivo / Sí:** Pelvis cae → **hp_gtps_cluster**
- **Negativo / No:** Trendelenburg negativo → **hp_mild**

24. [TEST / GATE] FABER / Patrick

id: hp_lateral_faber_screen

testId: faber

Descripción: Flexión, abducción y rotación externa de cadera (figura 4). Dolor inguinal vs. lumbar.

Procedimiento: Flexión, abducción y rotación externa de cadera (figura 4). Dolor inguinal vs. lumbar.

Evidencia: Registra DÓNDE duele: ingle → cadera; posterior → SI/lumbar; lateral → GTPS. Inespecífico como diagnóstico único.

→ **Positivo / Sí:** Dolor inguinal profundo → **hp_lateral_hip_joint**

→ **Negativo / No:** Sin dolor inguinal → **hp_lateral_lumbar**

25. [CONCLUSIÓN] Dolor referido lumbosacro / SI

id: hp_extraarticular

Resumen: FABER con dolor posterior sugiere origen extraarticular.

Hipótesis:

- **Disfunción articulación sacroilíaca** (media) — Dolor posterior sacroilíaco.

- **Dolor lumbar referido** (media) — Explorar SLR/Kemp si irradiación.

→ Nodo terminal (fin de rama).

26. [CONCLUSIÓN] Cuadro leve de cadera

id: hp_mild

Resumen: Tests especiales no concluyentes.

Hipótesis:

- **Sobrecarga / bursitis trocantérica leve** (media) — Dolor lateral sin signos intraarticulares.

→ Nodo terminal (fin de rama).

27. [CONCLUSIÓN] Posible participación de cadera intraarticular

id: hp_lateral_hip_joint

Resumen: Dolor inguinal profundo además de lateral → considerar coexistencia hip joint + GTPS.

Hipótesis:

- **Patología intraarticular de cadera (FAI/labrum/OA)** (media) — FABER inguinal positivo; valorar FADIR/ROM si procede.

- **GTPS coexistente** (media) — Patologías laterales e intraarticulares pueden coexistir.

→ Continúa en: **hp_fadir**

28. [CONCLUSIÓN] Enrutar por localización exacta

id: hp_master_location

Resumen: Anterior/medial/pubis/inguinal → groin Doha + FABER. Lateral → Trendelenburg. Posterior → SLR. Profundo → FADIR.

Hipótesis:

- **Groin Doha (adductor / iliopsoas / inguinal / pubic)** (alta) — Dolor inguinal o medial predominante.

- **Hip-related groin (intraarticular)** (media) — Dolor profundo inguinal + flexión/rotación mecánica.

- **Lateral / posterior** (media) — Trocánter o glúteo/isquion según mapa corporal.

→ Continúa en: **hp_groin_doha**

29. [CONCLUSIÓN] Compatible con deep gluteal / irritación ciática

id: hp_posterior_deep_gluteal

Resumen: Dolor glúteo profundo + empeora sentado + posible parestesia sin patrón isquial claro.

Hipótesis:

- **Deep gluteal syndrome** (alta) — Patrón sentarse + glúteo profundo.
 - **Piriformis-related** (media) — Diagnóstico de exclusión; no confirmar por un test.
 - **Ischiofemoral impingement** (baja) — Dolor posterolateral profundo.
- Nudo terminal (fin de rama).

30. [TEST / GATE] Trendelenburg

id: `hp_lateral_trendelenburg`

testId: `trendelenburg`

Descripción: Apoyo monopodal: caída de pelvis contralateral indica debilidad glútea media.

Procedimiento: Apoyo monopodal: caída de pelvis contralateral indica debilidad glútea media.

Evidencia: Grimaldi & Fearon JOSPT 2015: cluster GTPS (palpación + carga monopodal). Caída pélvica ≠ rotura de glúteo; también L5.

→ **Positivo / Sí:** Pelvis cae / dolor lateral familiar → **hp_gtps_cluster**

→ **Negativo / No:** Sin caída pelviana → **hp_lateral_lumbar**